

**ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ**



**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Реестр особых физиологических состояний

**УТВЕРЖДАЮ**

Министр здравоохранения  
Российской Федерации

\_\_\_\_\_ М.А. Мурашко  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 г.

**МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ**

**по обучению персонала, работающего с лицами, состоящими  
на учёте в Реестре особых физиологических состояний**

**ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ**

г. Москва, 2021 г.

## ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ

По итогам обучения (20 часов) персонал должен уметь:

- 1) выявлять и регистрировать случаи в соответствии с порядком, установленным настоящим пособием;
- 2) проводить первичный контакт и получать информированное согласие;
- 3) соблюдать требования конфиденциальности;
- 4) применять уровневый порядок обслуживания;
- 5) действовать при неотложных ситуациях и взаимодействовать с органами (МВД, МЧС, Роспотребнадзор).

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее пособие устанавливает порядок обучения и работы персонала, осуществляющего учёт и сопровождение лиц, состоящих на учёте в Реестре особых физиологических состояний (далее — Реестр).

1.2. Пособие подготовлено Реестром Министерства здравоохранения Российской Федерации и предназначено для территориальных органов здравоохранения во всех субъектах Российской Федерации.

1.3. Принципы работы: информированность, добровольность, конфиденциальность, бесконтактность в отношении лиц третьего уровня.

## 2. ВЫЯВЛЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ

### 2.1. Источники информации

Выявление осуществляется по линии здравоохранения:

- медицинские организации сообщают об аномальной концентрации ионов серебра в крови;
- территориальные органы Роспотребнадзора участвуют в эпидемиологическом мониторинге;
- информация о событиях, связанных с лицами третьего уровня, поступает через МВД России в рамках служебного взаимодействия;
- самообращение не предусмотрено; лицо не осведомлено о постановке на учёт.

### 2.2. Регистрация

Дело регистрируется в день подтверждения сведений. Номер дела: код субъекта — год — порядковый номер. Реестр ведётся на автономном офлайн-сервере.

### 2.3. Контрольный перечень (чек-лист) первичной регистрации

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> 1. Сведения получены и зафиксированы.</li><li><input type="checkbox"/> 2. Дело зарегистрировано, номер присвоен.</li><li><input type="checkbox"/> 3. Координатор назначен.</li><li><input type="checkbox"/> 4. Первичный контакт спланирован.</li><li><input type="checkbox"/> 5. Конфиденциальность обеспечена.</li></ul> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 3. ПЕРВИЧНЫЙ КОНТАКТ И СОГЛАСИЕ

3.1. Первичный контакт осуществляется двумя специалистами. Специалисты представляются, сообщают цель визита, предлагают варианты поддержки, проводят разъяснение по информированному согласию.

3.2. Принудительное помещение без согласия не допускается. Лицо вправе отказаться; отказ не влечёт неблагоприятных последствий.

3.3. Специалист разъясняет: наличие ионов серебра в крови в непатологической концентрации; связь эмоционального состояния с состоянием здоровья; перечень бесплатных услуг. Запрещается использование религиозных или псевдорелигиозных формулировок.

3.4. Согласие оформляется письменно; копия выдаётся лицу.

## **4. УРОВНЕВЫЙ ПОРЯДОК ОБСЛУЖИВАНИЯ**

### **4.1. Первый уровень**

Лица первого уровня после информирования самостоятельно решают вопрос о регулярном наблюдении. Предоставляются бесплатная медицинская помощь и социальная поддержка.

### **4.2. Второй уровень**

Лица второго уровня получают содействие в социальной интеграции: регистрацию, социальный номер, почтовый адрес, легальную административную позицию. Трудоустройство — на должностях с малым объёмом речевого общения (лесной наблюдатель, наблюдатель метеостанции, церковный помощник).

### **4.3. Третий уровень**

Лица третьего уровня находятся под полностью бесконтактным наблюдением. Специалисты не приближаются, не маркируют, не опрашивают. Ежегодно МЧС России размещает предметы первой необходимости на расстоянии не менее одного километра от границы территории. О факте жизни судят по исчезновению предметов. Координаты территорий хранятся на офлайн-сервере; доступ имеют только Министр и два уполномоченных заместителя.

### **4.4. Четвёртый уровень и выше**

Подтверждённых живых лиц четвёртого уровня не установлено. В отношении исторического случая («Скиф») сохраняется пассивный режим ожидания сигнала.

## **5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**

Сведения о лицах являются конфиденциальными. Персонал подписывает обязательство о неразглашении (бессрочное, в том числе после прекращения трудовых отношений). Сведения не обсуждаются в публичных местах и не разглашаются неуполномоченным лицам.

## **6. ОСОБЫЕ СЛУЧАИ**

### **6.1. Осведомление супруга (партнёра)**

Вопрос об осведомлении супруга (партнёра) решается в каждом случае индивидуально. Уведомление проводится только с согласия лица и в объёме, не превышающем известные медицинские факты. Настоящее пособие не устанавливает обязательной процедуры; решение принимает координатор с учётом обстоятельств. Принудительное уведомление не допускается.

## 6.2. Взаимодействие с органами

При необходимости персонал взаимодействует с МВД России (события, создающие риск), МЧС России (размещение предметов), органами местного самоуправления. Сведения передаются в объёме, необходимом для выполнения задач.

## 7. НЕОТЛОЖНЫЕ СИТУАЦИИ

К неотложным относятся: ситуация, создающая риск для жизни или здоровья лица или окружающих; изменение границ территории лица третьего уровня. Порядок: немедленное сообщение координатору, оценка, взаимодействие с МЧС, МВД. Принудительные меры самостоятельно не принимаются.

## 8. ОТЧЁТНОСТЬ

Территориальные органы ежеквартально представляют сводные данные в Реестр. Искажение данных не допускается.

## 9. ОБУЧЕНИЕ И КОНТРОЛЬ

Персонал проходит первоначальное обучение (не менее 20 часов), включая настоящее пособие, коммуникативные методики, требования конфиденциальности и разбор ситуаций. Проводится экзамен. Переподготовка — один раз в два года.

### Контрольные вопросы (пример)

1. Куда направляется информация о выявленном случае? ( )  
А. В МВД Б. В Реестр (по линии здравоохранения) В. В СМИ Г. Не направляется
2. Можно ли принудить лицо к наблюдению? ( )  
А. Да Б. Нет В. По решению МВД Г. В исключительных случаях
3. Как осуществляется наблюдение за лицом третьего уровня? ( )  
А. Бесконтактно; по исчезновению предметов Б. Ежедневным обходом В. По телефону Г. Не осуществляется
4. Осведомление супруга проводится: ( )  
А. Всегда Б. Только с согласия лица, индивидуально В. По решению МВД Г. Никогда
5. Запрещается ли использование религиозных формулировок? ( )  
А. Да Б. Нет В. Только при отказе Г. По усмотрению

## ПРИЛОЖЕНИЯ

### Приложение А — Учётная форма

№ дела: \_\_\_\_\_ Дата: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Орган: \_\_\_\_\_ Субъект: \_\_\_\_\_  
Источник: [ ] мед.организация [ ] Роспотребнадзор [ ] МВД [ ] иное  
Уровень: [ ] I [ ] II [ ] III [ ] IV [ ] V  
Заполнил: \_\_\_\_\_ Проверил: \_\_\_\_\_

### Приложение Б — Лист первичного контакта

№ дела: \_\_\_\_\_ Дата: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
 Способ контакта: [ ] визит [ ] приём [ ] иное  
 Разъяснение проведено: [ ] да [ ] отложено  
 Ответ лица: [ ] согласие [ ] отказ [ ] не определен  
 Специалисты: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

### Приложение В — Информированное согласие

Я получил(а) разъяснение известных медицинских фактов о моём состоянии и перечне доступных услуг. Я согласен(на) / отказываюсь (нужное подчеркнуть).  
 Подпись: \_\_\_\_\_ Дата: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
 Свидетель: \_\_\_\_\_

### Приложение Г — Обязательство о неразглашении

Я обязуюсь не разглашать сведения о лицах, состоящих на учёте, бессрочно, в том числе после прекращения трудовых отношений.  
 Ф.И.О.: \_\_\_\_\_ Должность: \_\_\_\_\_ Дата: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

### Приложение Д — Справка об осведомлении супруга (партнёра) (при необходимости)

Основание: \_\_\_\_\_ Согласие лица получено: [ ] да Присутствовали: лицо / супруг(а) /  
 сотрудники Сообщено: известные медицинские факты, перечень услуг Подтверждение подписано: [ ]  
 да Сотрудник: \_\_\_\_\_

### Приложение Е — Форма ежеквартальной отчётности

Субъект: \_\_\_\_\_ Период: \_\_\_\_/\_\_\_\_ — \_\_\_\_/\_\_\_\_  
 Состоит на учёте: \_\_\_\_ Новых: \_\_\_\_  
 Уровень I: \_\_\_\_ II: \_\_\_\_ III: \_\_\_\_ IV: \_\_\_\_  
 Отказов от наблюдения: \_\_\_\_ Ответственный: \_\_\_\_\_

### Приложение Ж — Лист подготовки кадров

Курс: работа с лицами, состоящими на учёте Дата: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
 Ф.И.О.                      Организация                      Подпись  
 1. \_\_\_\_\_  
 2. \_\_\_\_\_  
 3. \_\_\_\_\_  
 4. \_\_\_\_\_  
 (продолжение на отдельном листе)

Руководитель Реестра особых физиологических состояний

\_\_\_\_\_ И.О. Фамилия

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2021 г.

Исполнитель: \_\_\_\_\_, тел. (495) \_\_\_\_\_